



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ورده عبدالودود عبدالمحسن عبدالعاطي
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : بولاق ابو العلا

رقم البطاقة : 27702072500608 رقم التليفون : 01007371565 تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026
العنوان : --
العمر (تاريخ الميلاد) : 07-02-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (.....)
المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر بالصبغه
[11127]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ورده عبدالودود عبدالمحسن عبدالمعاط National ID: 27702072500608	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest and abdomen
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ورده

عبدالودود عبدالمحسن عبدالعاطي

١٩ ش احمد على اسماعيل

بولاق الدكرور - الجيزه

١٩٧٧/٠١/٠٧



٢٧٧.٢.٧٢٥.٠.٦ - ٨

K03124675

Nation ID - Palestine
[[DOC type ID]]



٢٠٢٤/٠٥ ٢٧٧.٢٠٧٢٥٠٠٦٠٨

ربة منزل



انثى مسلمة متزوجة

احمد عبدالوهاب محمد عبدالعاطي

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٥/١٩

١



Nation ID - Back
[DOO YPLAW-202403]



التاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٨

الاسم / وردة عبد الوادود

Ultrasonography of the Abdomen

Liver :

Size ☒ Normal ☐ Small ☐ Enlarged (☐ Mild - ☐ Moderate ☐ Marked)
Surface ☒ Smooth ☐ Irregular
Texture ☒ Normal ☐ Coarse ☐ Heterogeneous ☒ Bright
P.V. ☒ Normal ☐ Dilated
Biliary radicles ☒ Normal ☐ Dilated CBD ☐ Normal ☐ Dilated
Hepatic Veins ☒ Normal ☐ Dilated ☐ Attenuated
Focal Lesions ☒ No ☐ Others

Gall Bladder :

Size ☒ Average ☐ Contracted ☐ Distended ☐ Removed
Wall Thickness : ☒ Normal ☐ Thickened
Mud ☒ No ☐
Stones ☒ No ☐

Spleen :

Size ☒ Average ☐ Enlarged (☐ Mild - ☐ Moderate ☐ Marked)
Echopattern : ☒ Normal ☐

Kidneys :

	Rt.	Lt.
Size :		
Parenchymal thickness :	Rt Renal	
Parenchymal echopattern :	Simple cortical	
Focal lesion :	Cyst 33 mm	
Stones :		
Back pressure :		

Pancreas : ☒ Normal ☐
Ascites : ☒ Non ☐ Mild ☐ Moderate ☐ Marked
Aorta and para aortic nodes : Normal ☒
Urinary bladder ☒ No stones ☐
Prostate : ☒ Normal ☐ Enlarged (vol. = cm³)

Impression : Bulky uterus with post. wall fibroid
47x37 mm

Signature

Dr. [Signature]

fatty liver
Rt Renal Simple Cyst
uterine fibroid



Name: Warda 3 Abdelwadoud 45 Y, female

Date : 11/8/2026

Pelviabdominal ULTRASOUND

-**liver**: size in MCL : 13.2cm , texture : bright, surface : smooth , hepatic veins : normal , PV: not dilated , IHRs : not dilated , signs of fibrosis or cirrhosis : no , F.Ls: no

-**GB**: size : average, shadow inside : no , wall thickness : thin , CBD : not dilated.

Pancreatic area : average size , free .

-**Spleen** : long axis : 8.9cm , texture : homogenous , SP.V and collaterals : not dilated

-**Kidneys** : both are of normal position , texture : normal , back pressure : no , cysts : no , solid masses : no , stones : sandy , size : [11.6x4.7 cm , 11.3x4.3cm]

-**Pelvis**:-UB: many internal echoes

- uterus & adenexa : a big heterogenous mass ? uterine versus adenexal : 5.1x5.0x5.2 cm for gynecological exam

-Ascites : no, pleural effusion : no

*Conclusion :

.Bright liver ? fatty , an umbilical hernia with defect : 1.4 cm , perumbilical one with defect : 5.2 cm.

.Bilateral renal sandy stones .

.severe Colonic distension , pelvis as above .

BEST REGARDS
MANAL SHAKER

The General Organization for Teaching
Hospital and Institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital



إمسية العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفى أحمد ماهر التعليمي



اسم المريض : ورده عبد الودود عبد المحسن عبد العا	السن : 49 سنة
محول من :	(2026) (1743 - 2026)
تاريخ الحضور : 2026/07/07	تاريخ الإستلام : 2026/07/20

NATURE OF SPECIMEN :

Left breast mass, tru-cut biopsy.
Left axillary pathological lymph nodes, tru-cut biopsy

GROSS :

Two specimens are received designated as:

- 1) Left breast: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.5cm long, totally submitted.
- 2) Left axillary lymph node: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.7cm long, totally submitted.

MICROSCOPY :

- 1) Sections examined revealed mammary tissue cores showing sheets, and clusters of malignant epithelial cells infiltrating among desmoplastic stroma.
Tumor cells show moderate pleomorphism and moderate tubule formation.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern)
Positive lymphovascular emboli.
- 2) Sections examined revealed lymph nodal tissue infiltrated by the same tumor seen in the breast.

DIAGNOSIS :

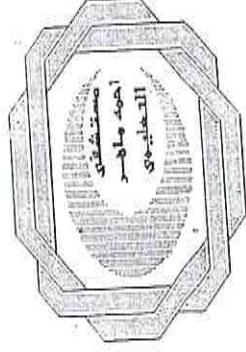
- 1) Left breast mass, tru-cut biopsy;
Invasive duct carcinoma, provisional core grade II.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern)
Positive lymphovascular emboli.
- 2) Left axillary lymph nodes, tru-cut biopsy;
Metastatic Invasive duct carcinoma to the lymph node.

RECOMMENDATION :

Prof. Dr. Rasha Farouk, MD.

رقم البطاقة: 27702072500608

The General Organization for Teaching
Hospital and Institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital



رئاسة العامة للتعليمات والمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفى أحمد ماهر التعليمي

اسم المريض : ورده عبد الودود عبد المحسن عبد الصا
محول من :
تاريخ الحضور : 2026/07/20

السن : 49 سنة
(2026) (1743 - 2026)
تاريخ الإستلام : 2026/08/05

NATURE OF SPECIMEN :

One paraffin block (Left breast mass, tru-cut biopsy)

GROSS :

One paraffin block: sections immunostained for ER, PR, Her-2/neu, ki67, using supersensitive monoclonal antibodies with En- Vision TM+ (HRP) detection system employing peroxidase after antigen retrieval and blocking internal peroxidase and using DAB as chromogen using BenchMark GX automated immunostainer

MICROSCOPY :

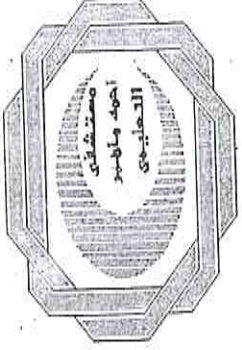
Estrogen receptors: Strong nuclear staining in 90 % of tumor cells.
Progesterone receptors: Moderate nuclear staining in 50% of tumor cells.
Her-2/neu: No membranous staining of tumor cells.
Ki67: Positive nuclear staining in 15 % of tumor cells.

DIAGNOSIS :

POSITIVE ESTROGEN RECEPTORS, SCORE 8/8.
POSITIVE PROGESTERONE RECEPTORS, SCORE 6/8.
NULL HER-2/neu, SCORE 0
Ki67: POSITIVE IN 15% OF TUMOR CELLS.

RECOMMENDATION :

Prof Dr Rasha Farouk, MD



قسم الباثولوجي

السن : 49 سنة

(2026) (1743 - 2026)

تاريخ الإستلام : 2026/07/20

إسم المريض : ورده عبد الودود عبد المحسن عبد العا

محول من :

تاريخ الحضور : 2026/07/07

NATURE OF SPECIMEN :

Left breast mass, tru-cut biopsy.
Left axillary pathological lymph nodes, tru-cut biopsy

GROSS :

Two specimens are received designated as:

- 1) Left breast: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.5cm long, totally submitted.
- 2) Left axillary lymph node: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.7cm long, totally submitted.

MICROSCOPY :

1) Sections examined revealed mammary tissue cores showing sheets, and clusters of malignant epithelial cells infiltrating among desmoplastic stroma.
Tumor cells show moderate pleomorphism and moderate tubule formation.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern)
Positive lymphovascular emboli.

2) Sections examined revealed lymph nodal tissue infiltrated by the same tumor seen in the breast.

DIAGNOSIS :

- 1) Left breast mass, tru-cut biopsy;
Invasive duct carcinoma, provisional core grade II.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern)
Positive lymphovascular emboli.
- 2) Left axillary lymph nodes, tru-cut biopsy;
Metastatic Invasive duct carcinoma to the lymph node.

RECOMMENDATION :

Prof. Dr. Rasha Farouk, MD.

رقم البطاقة: 27702072500608

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد
مستشفى أحمد ماهر التليوي

The General Organization for Teaching Hospitals
and Institutes

Ahmad Maher Teaching Hospital

Patient Name: *Warda Abdel Wadod Abdel-Mohsen*
Date: 1/7/2026

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

- Left axillary palpable lump.

Technique:

- CC and MLO views.
- High resolution ultrasound.

Findings:

- Scattered fibroglandular parenchyma. (ACR B).
- Left breast UOQ area of asymmetry.
- Left breast scattered macrocalcifications.
- No spiculated masses or grouped micro-calcifications.
- Complementary ultrasound showed both breasts are of normal texture.
- Left breast LOQ at 3-4 O'clock area of altered parenchyma.
- No internal vascularity on color Doppler.
- Left breast para-areolar at 6 O'clock single altered echotexture.
- No cystic or solid masses are detected.
- Normal skin thickness & nipple/areola complex.
- Right Non specific axillary lymphnodes.
- Left axillary pathological lymph nodes more than 3 groups.
- hilum largest measures 4x3.5 cm with irregular margins.
- Level II&III pathological lymph nodes.
- No evidence of supraclavicular lymph nodes.

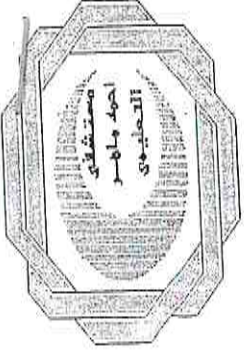
Conclusion:

- Left breast area of altered parenchyma with ipsilateral axillary lymph nodes for histopathological assessment. (BIRADS 4c).
- Left breast ductectasia.
- Right breast normal study (BIRADS 1)

Recommendations:

- Fine cut biopsy of left breast altered parenchyma and left axillary lymph nodes.

The General Organization for Teaching
Hospital and Institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital



الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفى أحمد ماهر التعليمي



اسم المريض : ورده عبد الودود عبد المحسن عبد العا
محول من :
تاريخ الحضور : 2026/07/07
السن : 49 سنة
(1743 - 2026)
تاريخ الإستلام : 2026/07/20

NATURE OF SPECIMEN :

Left breast mass, tru-cut biopsy.
Left axillary pathological lymph nodes, tru-cut biopsy

GROSS :

Two specimens are received designated as:

- 1) Left breast: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.5cm long, totally submitted.
- 2) Left axillary lymph node: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.7cm long, totally submitted.

MICROSCOPY :

- 1) Sections examined revealed mammary tissue cores showing sheets, and clusters of malignant epithelial cells infiltrating among desmoplastic stroma.
Tumor cells show moderate pleomorphism and moderate tubule formation.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern)
Positive lymphovascular emboli.
- 2) Sections examined revealed lymph nodal tissue infiltrated by the same tumor seen in the breast.

DIAGNOSIS :

- 1) Left breast mass, tru-cut biopsy;
Invasive duct carcinoma, provisional core grade II.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern)
Positive lymphovascular emboli.
- 2) Left axillary lymph nodes, tru-cut biopsy;
Metastatic Invasive duct carcinoma to the lymph node.

RECOMMENDATION :

Prof. Dr. Rasha Farouk, MD.

رقم البطاقة: 27702072500608

Ahmad Maher Teaching Hospital

Patient Name: *Warda Abdel Wadod Abdel Hachem*
Date: *1/7/2026*

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

- Left axillary palpable lump.

Technique:

- CC and MLO views.
- High resolution ultrasound.

Findings:

- Scattered fibroglandular parenchyma (BIRADS 1).
- Left breast UOQ area of asymmetry.
- Left breast scattered macrocalcifications.
- No spiculated masses or grouped micro-calcifications.
- Complementary ultrasound showed both breasts were of normal texture.

MIC

- Left breast LOQ at 3-4 O'clock area of altered parenchyma.
- No internal vascularity on color Doppler.

DIAGN

- 1. Left breast para-areolar at 6 O'clock single ill-defined short-segment
F. nuclear echogenic non-vascular content.
- 2. No cystic or solid masses are detected.
- M. Normal skin thickness & nipple/areola complexes.
- 1. Right Non specific axillary lymph nodes.
- 1. Left axillary pathological lymph nodes more than 3 axillary
hilum largest measures 4x3.5 cm with irregular margins.
- 2. Level II&III pathological lymph nodes.
- M. No evidence of supraclavicular lymph nodes.

RECOMME

Pt

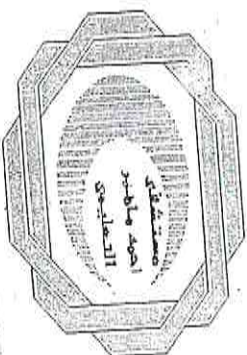
Conclusion:

- Left breast area of altered parenchyma with ipsilateral axillary lymph nodes for histopathological assessment (BIRADS 4a).
- Left breast ductectasia
- Right breast normal study (BIRADS 1)

Recommendations:

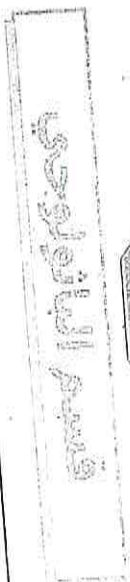
- Try cut biopsy of left breast altered parenchyma and lymph nodes.

General Organization for Teaching
and Institutes
Maher Teaching Hospital



الهيئة العامة للتعليم والتقنية

مستشفى أحمد ماهر التعليمي



السن : 49 سنة

2026) (1743

2026)

تاريخ الاستلام : 2026/07/20

اسم المريض : وردة عبد الودود عبد المحسن عبد العا
محول من :

تاريخ الحضور : 2026/07/07

TURE OF SPECIMEN :

Left breast mass, tru-cut biopsy.
Left axillary pathological lymph nodes, tru-cut biopsy

ROSS :

- Two specimens are received designated as:
- 1) Left breast: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.5cm long, totally submitted.
 - 2) Left axillary lymph node: Multiple gray white tissue cores the longest measured 1.7cm long, totally submitted.

MICROSCOPY :

- 1) Sections examined revealed mammary tissue cores showing sheets, and clusters of malignant epithelial cells infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells show moderate pleomorphism and moderate tubule formation. Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern). Positive lymphovascular emboli.

- 2) Sections examined revealed lymph nodal tissue infiltrated by the same tumor seen in the breast.

DIAGNOSIS :

- 1) Left breast mass, tru-cut biopsy;
Invasive duct carcinoma, provisional core grade II.
Intermediate grade DCIS, 10% (Solid pattern).
Positive lymphovascular emboli.

- 2) Left axillary lymph nodes, tru-cut biopsy;
Metastatic Invasive duct carcinoma to the lymph node.

RECOMMENDATION :

Prof. Dr. Rasha Farouk, MD.

رقم البطاقة: 27702072500608



Date	17-8-2026	Age
Name	Warda abd el wadood	
Referred by		

2D and M mode measurements in mm				
parameter	28	Normal	parameter	Normal
Aortic root	26		IVS	0.8
Left atrium	28		PWT	0.7
LV EDD	39		Fractional Shortness	33
LV ESD	26		Ejection Fraction	62
				>25%
				55-80%

Cardiac Valves :

- Mitral valve: Normal morphology
- Aortic valve: normal l aortic valve
- Tricuspid valve: Normal morphology.
- Pulmonary valve: Normal morphology and flow.

Comment

- Intact inter atrial and interventricular septi
- Normal doppler study
- good left ventricular systolic function with EF 62% by 2D and by visual estimation .
 - Left ventricle: normal LV internal dimensions.
 - Normal LV thickness and septum .
 - NRSWMA
- Right atrium: normal .
- Right ventricle: normal RV dimensions and normal function
- No thrombi or vegetations could be detected in LV.
- Normal pericardium NO pericardial effusion.

Conclusion:

Normal Echodoppler study

Much Obliged
Dr. A.ghazi